

Amro1

J'attends vos réponses. Vous n'évoquez rien du tout ? Une crise d'asthme modérée. D'accord.

Pourquoi, à votre avis, vous avez classé cette crise d'asthme en étant une crise d'asthme modérée ? Oui. Alors, comment vous allez juger cette crise d'asthme ? Il y a une proposition de réponse que vous avez mise. C'est une crise modérée.

Maintenant, ma question, quel sont vos arguments en faveur de classer cette crise qu'en étant modérée ? Alors, les différents éléments, elles sont déjà asthmatiques. Alors, le fait que la patiente soit asthmatique n'est pas forcément en faveur d'une crise modérée. Ça veut dire que la patiente est asthmatique.

Point bas. Mais, pour évaluer la crise et la notifier qu'elle est modérée sur cet argument-là, non. Maintenant, oui, la saturation est de 91%.

Oui, la fréquence, les données de la fréquence cardiaque, la fréquence respiratoire. C'est une personne qui continue, qui arrive à parler, qui arrive à articuler, même si, je vous ai marqué ici, elle répondait, mais elle arrêta, elle s'arrêta de temps en temps. Mais, en tout cas, c'est quand même une personne avec laquelle on arrive à communiquer.

Donc, c'est une crise de sévérité modérée, mais pas très importante. C'est ce que vous avez mis. On a un 2P qui est plus de 60%, une saturation qui est plus de 90%.

Donc, la crise ici est modérée. Est-ce qu'il y a des facteurs favorisant, à votre avis, est-ce qu'il y aurait des facteurs favorisant à la survenue de cette crise? On remet la vignette. Le train.

Alors, argumentez votre réponse. Pourquoi le train a-t-il fait ça sur cette patiente? Alors, le tabagisme, il va entretenir l'inflammation. C'est aussi un facteur de risque de survenue d'une crise.

Et aussi, parce qu'il diminue l'efficacité de la corticothérapie inhalée. Donc, il rend le traitement moins efficace. Donc, c'est un facteur qui pourrait favoriser la survenue d'une exacerbation.

Est-ce qu'il y a un autre argument qui pourrait justifier aussi la survenue de cette crise? Un chat domestique. C'est possible. Si on est exposé, encore une fois, à cette allergène.

Tout à fait. Une exposition allergénique importante pourrait expliquer cette aggravation. Quoi d'autre? Antécédent d'un grave.

Ça fait partie d'une autre facteur. C'est-à-dire, ça fait partie des facteurs de gravité, si vous voulez, oui. Mais quand vous voyez, je vous ai mis cette slide.

C'est une personne qui ne prend pas correctement son traitement. Parce que de temps en temps, elle vous dit qu'elle prend du salbutamol en aerosol doseur à la demande. Et de temps

en temps, elle prend son corticothérapie inhalée.

Or, pour l'asthmatique, c'est plutôt l'inverse. La corticothérapie inhalée, c'est le traitement de fond. Et puis, en cas de besoin, on va utiliser un bêta2-agoniste pour durée d'action.

Donc là, il y a une mauvaise appréciation ou une adhérence au traitement. Ceci favoriserait, comme je vous ai dit, la survenue de la crise d'asthme. Alors là, je vous ai présenté sur cette slide les critères de sévérité de la crise d'asthme.

Mais ça, vous l'avez en cours. Donc vous voyez, pour cette patiente, elle continue toujours incontinuellement à parler. Elle a une fréquence respiratoire augmentée de moins de 30.

Des sibilons et sans diffus. Un DEP qui est entre 60 et 80. Et vous avez une saturation qui est de 91.

Donc on va classer notre crise d'asthme en crise modérée. C'est comme ça qu'on procède. Sur des items, des paramètres bien identifiés.

Comment qualifieriez-vous le contrôle de l'asthme de cette patiente au cours des semaines qui précèdent son admission aux urgences? Je vous remettrai la vignette. La question, voilà. Oui, mais ce n'est pas la réponse, la mauvaise observance.

Maintenant, la question, c'est comment vous allez évaluer, en fonction de la vignette que je vous ai montrée, le contrôle de l'asthme chez cette malade. Comment vous le jugez? Avant, bien évidemment, son admission aux urgences. Alors vous avez mis non contrôlé.

Justifiez votre réponse. Non, ce n'est pas ça. Comment ça des crises d'asthme qui n'existent pas au traitement? Bon, on ne parle pas ici de crise d'asthme.

On parle du contrôle de l'asthme. Recouvre au salbutamol plusieurs fois par jour, très bien. Les réveils nocturnes, tout à fait.

Donc je vous remets ici la vignette. Alors le contrôle, je vous ai dit que la patiente vous dit, depuis quelques semaines, elle prenait le salbutamol plusieurs fois par jour, donc l'utilisation de l'hématite plusieurs fois par jour. Les réveils nocturnes, plusieurs fois par semaine.

Elle avait du mal à monter les escaliers, donc c'est un impact sur l'activité physique qui est perturbé. Puis ça s'est majoré la dernière semaine. Donc ça revient à parler, parce que je vois que je repose une autre question.

C'est quoi le contrôle de l'asthme? Donc voilà la réponse, c'est un asthme non contrôlé, car il y a présence de plus de caractéristiques de non contrôle de l'asthme, des épisodes durs, limitation d'activité physique, présence des symptômes nocturnes, recours à des traitements plusieurs fois par jour, par semaine, donc voilà, c'est un asthme qui n'est pas contrôlé. Donc ma question, comment on a répondu à cette question? C'est-à-dire là, il faut comprendre la notion du contrôle. Voilà, les critères de contrôle, quand on parle du contrôle de l'asthme, c'est un contrôle de

la maladie de fang, ce n'est pas un contrôle de crise.

Et pour dire que c'est un asthme qui est contrôlé ou bien il n'est pas contrôlé, c'est pas de l'improvisation, c'est sur des items bien identifiés. Quels sont ces items-là? Ce sont les suivants, les symptômes journaliers, la limitation des activités, les symptômes nocturnes, nécessité, recours aux traitements oncalgènes, c'est-à-dire au bêta de courte durée d'action, la fonction respiratoire et les exacerbations. Mais si ces caractéristiques-là ne sont pas présents et sont satisfaisants, on parle d'un asthme contrôlé, sinon il est partiellement contrôlé.

Et si vous avez trois des items qui se font perturber avec une exacerbation au cours de la semaine, c'est un asthme qui n'est pas contrôlé. Et le contrôle de l'asthme, il se fait sur plusieurs semaines, donc on fait une évaluation sur quatre semaines. Donc c'est pour ça que la question de tout à l'heure, si je reviens, c'était comment vous devriez qualifier ce contrôle de l'asthme au cours des semaines précédant son admission.

Donc la réponse était non contrôlée, justement, en vérifiant ces paramètres du contrôle. Et puisque dans l'interrogatoire, on arrive à identifier les items sur lesquels on va se prononcer et dire que c'est un asthme qui n'est pas contrôlé. Une autre question, est-ce que cette patiente, elle fait partie des patients à offre? Oui, le contrôle c'est par rapport à la maladie de faim.

Ce n'est pas le traitement de faim, on évalue l'asthme, on n'évalue pas ici un traitement, que ce soit ni le traitement de faim, ni le traitement de crise. Quand on parle de contrôle, c'est le contrôle de la maladie de faim, c'est-à-dire le contrôle de l'asthme. Et par rapport à quoi? Justement, c'est par rapport à ces caractéristiques que je vous ai représentées sur cette diapositive et que vous avez aussi sur votre cours.

Donc on contrôle la maladie sur ces items-là, ce n'est pas le traitement de faim, ce n'est pas le traitement de crise. Alors, est-ce que cette patiente fait partie des patients à risque de décès par asthme? Si oui, justifiez votre réponse. Sinon, pareil, quels sont vos arguments? Pour les observances, oui, elle fait partie des patients à risque, d'accord.

Le tabac, d'accord. Mais est-ce qu'il y a autre chose aussi à ajouter? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est aussi très pertinente, qui vous permettrait de dire que oui, cette patiente a un haut risque de décès par asthme? Très bien, c'est antécédent d'hospitalisation, pas hospitalisation tout court, mais un antécédent d'asthme aiguë grave. Voilà.

Elle vous a dit qu'il y avait un an, elle était hospitalisée pour un asthme aiguë grave. Le jeûnage, c'est un facteur, effectivement, antécédent d'hospitalisation pour asthme aiguë grave l'année précédente. Ne prend pas correctement ses traitements de fond, parce qu'il utilise la corticothérapie l'année de temps en temps, alors que c'est plutôt l'inverse.

Et puis, l'exposition du tabac, comme je vous ai dit, c'est aussi un facteur de risque de gravité. Là, on vous rappelle les patients à risque. Tout ça, vous l'avez sur votre cours.

Maintenant, quels traitements proposeriez-vous aux urgences pour cette patiente? Finalement,

c'est une patiente jeune de 24 ans qui a une crise d'asthme que vous avez jugée être modérée sur les arguments que nous avons déjà cités. Quelle est l'approche thérapeutique aux urgences? Bêta-doméétique inhalée. Quel type de bêta-doméétique? Tout à fait, d'action rapide.

Alors, l'oxygène, oui, il faut que la saturation soit plus de 95%. On va administrer les bêta-deux agonistes d'action rapide. Là, je vous ai mis quelques exemples de bêta-deux agonistes courte durée d'action à administrer de façon répétée.

Une corticothérapie orale de courte durée d'action, pas dans de courte durée, c'est pendant cinq jours au maximum. Alors, des fois, chez certains patients qui peuvent présenter des effets secondaires avec les bêta-deux mémétiques. Alors, bêta-deux mémétiques ou agonistes, c'est pareil.

Avec les bêta-deux mémétiques, essentiellement, qu'ils soient qui vont présenter des tremblements, une tachycardie importante, ou qui ne tolèrent pas justement l'administration de ventoline, de salbutamol, il faut savoir que les anticholinergiques peuvent également être utilisés parce que dans la deuxième famille des bronchodilatateurs, vous connaissez, il y a les anticholinergiques. Dans les anticholinergiques, il y a ceux qui sont de courte durée d'action et ceux qui sont de longue durée d'action. Alors, longue durée d'action, tout ce qui est traitement de fond, et les courtes durées d'action peuvent être utilisées en cas de crise.

C'est le bromure d'hypratropia, ou également appelé l'atrovain. Donc, ils peuvent être utilisés en deuxième intervention. Quels sont les éléments de surveillance de cette patiente au niveau des urgences? Qu'est-ce qu'on va assurer? Donc, on va administrer de l'oxygène, des bêtas bronchodilatateurs pour durée d'action, de la corticothérapie par voie orale ou par voie injectable.

Il faut surveiller quelque chose. Alors, quels sont les éléments de surveillance? Très bien, donc on va surveiller la saturation, tout à fait. On va surveiller la fréquence respiratoire, la fréquence cardiaque.

On va reprendre son débit expiratoire de pointe. On va ausculter la patiente pour voir si elle garde des signaux ou pas. Donc, c'est une évaluation clinique.

Il n'y a pas que la saturation et la fréquence. Donc, il faut voir s'il n'y a pas d'aggravation, c'est-à-dire par la mise en jeu des muscles respiratoires accessoires. La fréquence cardiaque et respiratoire, est-ce qu'elle arrive à parler convenablement? Il n'y a plus de cyanose.

Le débit expiratoire de pointe, on peut également le remesurer. Et la saturation en oxygène, on peut aussi évaluer. En raison de la bonne réponse au traitement et d'un entourage familial attentif, la sortie de la patiente a été autorisée au bout de six heures, avec un rendez-vous de consultation en une semaine et une ordonnance pour le traitement suivant.

Corticothérapie orale pendant six jours. Budézonide 200 microgrammes de bouffée deux fois par jour. Et salbutamol à la demande.

Elle est revue six jours plus tard en consultation. Elle vous dit aller beaucoup mieux et ne se plaint plus que d'une toux sèche, peu invalidante, son examen clinique est normal. Elle a réalisé une courbe débit-volume.

Sa courbe débit-volume est la suivante, interprétée. Alors ça, c'est une courbe débit-volume. J'ai des choses que vous avez déjà vues l'année dernière, en deuxième année, que je vous ai présentées au cours.

Maintenant, je vous demanderai de faire l'application pratique. J'attends votre proposition de réponse. D'accord, donc VMSF1F à 70, ça veut dire quoi ? Et quand on a un trouble ventilateur obstructif, qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce qu'on fait ? Très bien, alors maintenant, est-ce qu'il est réversible, ce trouble ventilatoire, chez votre patiente ou pas ? Et dans les deux cas de figure, vous justifiez votre réponse.

C'est-à-dire, si vous dites réversible, vous m'expliquez comment vous avez évalué cette réversibilité. Alors, écart supérieur à 12%, supérieur à 12%. Qu'est-ce qui est supérieur à 12% ? La réversibilité, vous allez la juger sur quels paramètres ? Sur le VMS.

Et je vous ai dit, redit et redit maintes fois, que la réversibilité va être jugée sur le VMS, d'accord. Il faut qu'il y ait une amélioration de 12%, oui, et un gain de 200 ml en valeur absolue. Alors, comment vous avez calculé le gain en valeur absolue ? C'est facile, vous allez faire comment cette mesure ? Il faut que les deux conditions soient réunies.

Il faut qu'il y ait l'amélioration de 12% et un gain de 200 ml sur le VMS. Donc, le gain de 200 ml sur le VMS est facilement calculable. Très bien, donc c'est le VMS Mesurez post-brancodilatateur et vous retranchez la valeur mesurée très test.

Donc là, c'est-à-dire, vous allez retrancher quoi de quoi ? Très bien, donc 2,35 moins 2,01. Et bien, vous avez que c'est plus de 200. Ensuite, on va mesurer effectivement cette amélioration de 12%.

Comment on va mesurer cette amélioration de 12% du VMS ? On prend le VMS2 moins le VMS1 sur le VMS1. Et bien sûr, puisque c'est un pourcentage, vous multipliez par 100. Et si vous retrouvez que c'est plus de 12%, avec une amélioration aussi, un gain plus de 200 ml, on va dire que c'est un trouble ventilatoire obstructif qui est réversible.

Donc, chez cette patiente, comme vous l'avez également dit, c'est un trouble ventilatoire obstructif. Et puis, effectivement, j'ai oublié de vous... Déjà, l'aspect de la courbe, il est important à regarder. Cette cassure, l'aspect concave de la courbe expiratoire, donc ça, c'est la courbe expiratoire et ça, c'est la courbe inspiratoire.

Et cette cassure-là, elle est très suggestive de l'obstruction. Et sur cette deuxième courbe, vous voyez qu'il y a déjà une amélioration. Vous avez les chiffres, ils sont plus intéressants.

Et après avoir visualisé l'aspect graphique de la courbe, on regarde de plus près les valeurs

mesurées. Donc là, vous avez effectivement dit que c'est un TVO qui est réversible. Très bien.

Quel traitement lui proposeriez-vous pour les six mois à venir ? Je vous remets la... Donc, voilà. Elle est revue six jours plus tard en consultation. Elle vous dit qu'elle va beaucoup mieux, ne se plante plus que d'une toux sèche préinvalidante.

Son examen clinique est normal. On a réalisé l'exploration fonctionnelle au moment de sa consultation. On l'a interprétée.

Maintenant, est-ce qu'on va modifier ou pas ? Est-ce qu'il y a un traitement à proposer pour les six mois à venir pour cette patiente ? Ce n'est pas tout à fait ça l'objectif. La dose minimale efficace, non. Est-ce qu'il y a d'autres réponses ? Alors, ce qu'on va prescrire, bien sûr, c'est l'arrêt du tabac.

Ça, c'est important. Comme je vous ai dit, elle rend responsable de certaines corticorésistances. Alors, il y a plusieurs choix thérapeutiques.

Comme il reste quand même un peu symptomatique, soit qu'on va augmenter la dose de la corticothérapie inhalée. Donc, on passe à une corticothérapie moyenne à forte dose. Soit qu'on va opter pour une association de corticothérapie inhalée faible dose associée à un bronchodilatateur longue durée d'action.

Ça, c'est le choix préférentiel. Et, bien sûr, avec une crise matin et soir. Ou bien, on peut ajouter aussi un antihélicotrienne.

Donc, rappelez-vous sur l'athlète que je vous ai mis sur le traitement de fond dans le cou. Il y a plusieurs choix thérapeutiques. Et, bien sûr, toujours l'état de médecine courte durée d'action en cas de gêne respiratoire.

Et dans l'éducation de la patiente, il faut absolument insister sur l'intérêt du traitement de fond qui doit être pris de façon continue. Alors que le traitement de crise, bien sûr, comme cela l'indique, on va utiliser en cas de crise d'asthme. Si la personne ne présente pas de signe en aiguë, elle utilise uniquement son traitement de fond.

Donc, le choix préférentiel serait d'associer une corticothérapie inhalée à faible dose associée à un bronchodilatateur longue durée d'action. Voilà, donc ça c'est quelques choix thérapeutiques. Bien sûr, vous avez ces choix dans vos cours.

La patiente est revue 6 mois plus tard. Elle prend son traitement à dose faible de corticoïdes inhalés, matin et soir, associé à un bronchodilatateur de longue durée d'action. Elle présente 2 à 3 réveils nocturnes par mois.

Et elle utilise le sel butamol 2 à 4 fois par mois. Son VMS, il est mesuré, il est à 2,7 litres. Comment évaluez-vous le contrôle et la sévérité de son asthme ? Eh bien, ici, la même chose.

On va revoir les critères de contrôle que nous avons déjà vus. Eh bien, c'est un asthme qui va

être contrôlé. Et de point de vue sévérité de la maladie, c'est un asthme qui va être considéré comme étant un asthme persistant, léger.

Parce qu'il a une fonction, en analysant sa fonction respiratoire et les symptômes, ça le classe en persistant, léger. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce cas clinique ? Très bien.

Donc, s'il n'y a pas de questions, on a terminé. Continuation. Et à la prochaine séance.

Au revoir. Sous-titres réalisés para la communauté d'Amara.org